Stakeholder Analysis dan Power–Interest Grid

Sistem Informasi Klinik Sehat Bersama

Nama : Parhan Septiyana

NIM : 2507019

1. Identifikasi Stakeholder

No	Stakeholder	Peran dan kepentingan
1	Pemilik Klinik	Penyandang dana; ingin kualitas layanan naik dan bisnis berkembang
2	Kepala Klinik	Pemimpin proyek; butuh sistem terintegrasi dan informasi untuk keputusan
3	Divisi IT	Implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan sistem
4	Dokter	Butuh akses cepat ke riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan pasien
5	Vendor Pengembang	Membangun dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan klinik
6	Perawat	Butuh sistem mudah untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien
7	Petugas Pendaftaran	Butuh pendaftaran lebih cepat agar antrean berkurang
8	Apoteker	Butuh informasi resep akurat dan stok obat yang selalu diperbarui
9	Petugas Kasir/Keuangan	Butuh pencatatan pembayaran dan laporan transaksi yang akurat
10	Pasien	Berharap pendaftaran dan pelayanan lebih cepat serta informasi akurat

2–4. Power, Interest, dan Alasan

Stakeholder	Power	Interest	Alasan
Pemilik Klinik	5	4	Menentukan anggaran dan arah proyek. Hasil sistem memengaruhi bisnisnya, tetapi ia tidak terlibat operasional harian.
Kepala Klinik	5	5	Memimpin proyek dan memutuskan prioritas. Sangat bergantung pada hasil sistem.
Divisi IT	4	5	Menguasai teknis dan keamanan sehingga berpengaruh kuat. Keberhasilan sistem menjadi tanggung jawab langsungnya.
Dokter	4	5	Penentu adopsi di layanan medis. Pekerjaannya sangat bergantung pada kecepatan akses data pasien.
Vendor Pengembang	4	3	Memegang kendali teknis pembangunan. Kepentingannya sedang karena terikat kontrak dan tidak memakai sistem sehari-hari.
Perawat	2	5	Tidak memutuskan proyek, tetapi pencatatan hariannya langsung berubah dan perlu adaptasi.
Petugas Pendaftaran	2	5	Suaranya terbatas dalam keputusan, tetapi kecepatan kerja dan antrean langsung dipengaruhi sistem.
Apoteker	3	4	Dapat memengaruhi desain modul resep dan stok, bukan penentu proyek. Akurasi data sangat penting bagi pekerjaannya.
Petugas Kasir/Keuangan	3	4	Dapat memengaruhi aturan pembayaran dan laporan, bukan penentu proyek. Akurasi transaksi menyangkut pekerjaannya.
Pasien	2	4	Tidak memutuskan proyek, tetapi pengalaman layanan dan akurasi informasi bergantung pada sistem.

5. Penempatan pada Power–Interest Grid

- **High Power – High Interest:** Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Divisi IT, Dokter
- **High Power – Low Interest:** Vendor Pengembang

- **Low Power – High Interest:** Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Petugas Kasir/Keuangan, Pasien
- **Low Power – Low Interest:** tidak ada

6. Strategi Pengelolaan

Posisi pada grid	Strategi
High Power – High Interest	Libatkan intensif dalam keputusan penting; rapat rutin dan demo per tahap.
High Power – Low Interest	Jaga kepuasan; kontrak dengan SLA dan jadwal jelas, laporan status ringkas.
Low Power – High Interest	Komunikasi rutin; pelatihan, uji coba bersama pengguna, dan kanal masukan.
Low Power – Low Interest	Monitor; pantau jika muncul pihak baru.

7. Penjelasan Kelompok Stakeholder

- **Dikelola secara dekat:** Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Divisi IT, dan Dokter. Mereka memutuskan anggaran dan prioritas, melaksanakan sistem, serta menentukan adopsi di layanan medis.
- **Dijaga kepuasannya:** Vendor Pengembang. Ia memegang kendali teknis, tetapi kepentingannya sedang karena terikat kontrak.
- **Dilibatkan melalui komunikasi rutin:** Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Petugas Kasir/Keuangan, dan Pasien. Mereka terdampak langsung tetapi tidak memutuskan proyek, sehingga perlu pelatihan dan wadah masukan.
- **Cukup dimonitor:** tidak ada stakeholder di kuadran ini.

8. Visualisasi Power–Interest Grid

